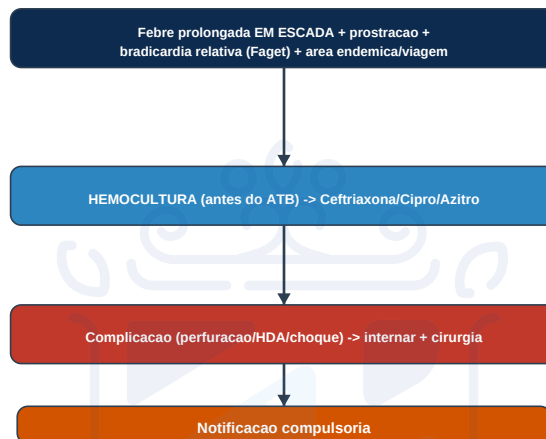


FEBRE TIFOIDE — FEBRE EM ESCADA + FAGET

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

FEBRE TIFOIDE — HEMOCULTURA -> ATB



DEFINIÇÃO E QUADRO CLÍNICO

FEBRE PROLONGADA EM FASES

- Doença sistêmica por *Salmonella enterica* sorotipo Typhi, transmissão FECAL-ORAL (água/alimentos); incubação 7-14 dias; endêmica em áreas com saneamento precário
- 1ª semana: febre alta em ESCADA (progressiva), cefaleia intensa, mialgia, tosse seca
- 2ª semana: prostração máxima, dor abdominal, diarreia 'ervilha' OU constipação, ROSÉOLAS tíficas, hepatoesplenomegalia
- 3ª semana: platô/declínio ou COMPLICAÇÕES (perfuração, hemorragia)
- BRADICARDIA RELATIVA (sinal de FAGET): dissociação pulso-temperatura; também língua saburrosa, 'estado tífico' (confusão); notificação compulsória

RED FLAGS — COMPLICAÇÕES (2ª-3ª SEMANA)

EMERGÊNCIAS

- PERFURAÇÃO intestinal (íleo terminal, 1-3%): dor abdominal súbita intensa, defesa/rigidez, pneumoperitônio — cirurgia
- HEMORRAGIA digestiva (10-30%): melena, hematêmese, hematoquezia, instabilidade
- Choque séptico; 'ESTADO TÍFICO' (confusão, delirium, estupor, coma)
- A PERDA da bradicardia relativa (taquicardia > 120) sugere complicação
- Sinais de gravidade: febre > 14 dias, prostração extrema, hipotensão, oligúria, icterícia (hepatite tífica)

DIAGNÓSTICO

HEMOCULTURA É O PADRÃO-OURO

- HEMOCULTURA (gold standard): melhor na 1ª semana (sens. 80-90%); coletar ANTES do antibiótico, 2-3 amostras
- Coprocultura (melhor após 2ª semana, identifica portador); mielocultura (mais sensível, invasiva, positiva mesmo com ATB prévio); urocultura
- Reação de WIDAL: baixa especificidade (muitos falso-positivos) — NÃO usar isoladamente; ELISA IgM mais específico
- Hemograma: LEUCOPENIA com desvio à esquerda (típico) ou normal; anemia, plaquetopenia leve, EOSINOPENIA; TGO/TGP elevadas; hiponatremia (SIADH)
- Imagem se complicação: RX abdome (pneumoperitônio), TC (perfuração/abscesso), USG

TRATAMENTO

Rx ATB APÓS COLETA DE CULTURAS

1ª escolha: Ceftriaxona 2 g EV/dia por 7-14 dias (preferencial se grave/resistência); Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12h por 7-10 dias (leve-moderado; atenção à resistência); Azitromicina 1 g D1 + 500 mg/dia por 5-7 dias

2ª escolha: Cloranfenicol (clássico, risco de aplasia medular); Ampicilina (resistência comum)

GRAVE (choque/complicações): Ceftriaxona 2 g EV 12/12h + DEXAMETASONA 3 mg/kg ataque, depois 1 mg/kg 6/6h por 48h (reduz mortalidade)

Duração 7-14 dias (mínimo 7 dias após a defervescência); ajustar ao antibiograma

Suporte: hidratação, antitérmico (Dipirona/Paracetamol; EVITAR AINE — sangramento), antiemético, dieta leve SEM resíduos (risco de perfuração), repouso

PERFURAÇÃO: cirurgia de emergência (rafia ± ressecção + lavagem) + ATB amplo + UTI

PORTADOR CRÔNICO, INTERNAÇÃO E ALTA

DECISÃO

- ☐ PORTADOR CRÔNICO (1-5%): coprocultura + > 1 ano -> Ciprofloxacino 500 mg 12/12h por 28 dias (ou Ampicilina + Probenecida 6 sem); colecistectomia se cálculos (S. typhi persiste na vesícula); fonte de transmissão (manipuladores de alimentos)
- ☐ INTERNAR: forma grave/'estado tífico', complicações (perfuração/HDA/choque), desidratação/intolerância oral, vômitos incoercíveis, confusão, dor abdominal intensa, < 2 anos/idoso/gestante/comorbidade
- ☐ ALTA: afebril 48h sem antitérmico, melhora clínica, tolerando VO, sem complicação, estável, seguimento garantido (completar ATB VO)
- ☐ Orientações: completar ATB (não interromper — risco de recidiva/portador), higiene rigorosa de mãos, NÃO manipular alimentos para terceiros até 2 coproculturas negativas, isolamento entérico domiciliar
- ☐ Seguimento: coprocultura de controle (3 amostras) ~1 mês após o fim do tratamento; notificação compulsória ao SINAN

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com febre tifoide (confirmada/suspeita); febre há ____ dias (em escada); procedência/viagem ____; água/alimentos suspeitos ____.
- Hemocultura ____; hemograma (leucopenia?) ____; Tax ____, FC ____ (Faget?), PA ____; roséolas ____; hepatoesplenomegalia ____.
- Complicação: perfuração (defesa/pneumoperitônio) ____ / HDA ____ / choque ____ / estado tífico ____.
- Conduta: hidratação, Ceftriaxona/Cipro ____ às ____, antitérmico; solicito internação enfermaria/UTI / cirurgia (perfuração); notificar SINAN.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual sinal clínico clássico (dissociação pulso-temperatura) é sugestivo de febre tifoide?

- A) Sinal de Murphy
- B) Bradicardia relativa (sinal de Faget)
- C) Sinal de Blumberg
- D) Sinal do sulco
- E) Sinal de Battle

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de febre tifoide, e quando colhê-lo?

- A) Reação de Widal isolada
- B) Hemocultura, preferencialmente na 1ª semana e antes do antibiótico
- C) Coprocultura na 1ª semana
- D) Sorologia IgG
- E) Urocultura

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a complicação mais temida da febre tifoide, geralmente na 2ª-3ª semana?

- A) Artrite reativa
- B) Perfuração intestinal (íleo terminal)
- C) Pancreatite
- D) Meningite
- E) Pneumonia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual alteração do hemograma é típica da febre tifoide?

- A) Leucocitose intensa com eosinofilia
- B) Leucopenia com desvio à esquerda e eosinopenia
- C) Linfocitose atípica
- D) Pancitopenia grave
- E) Policitemia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira escolha para a febre tifoide grave?

- A) Amoxicilina oral
- B) Ceftriaxona endovenosa
- C) Metronidazol
- D) Vancomicina
- E) Nitrofurantoína

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A bradicardia relativa (sinal de Faget) — frequência cardíaca que não acompanha a febre — é clássica da febre tifoide; sua perda (taquicardia) sugere complicação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hemocultura é o padrão-ouro, com maior sensibilidade na 1ª semana e devendo ser colhida ANTES do antibiótico; a reação de Widal tem baixa especificidade.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A perfuração intestinal (íleo terminal) é a complicação mais temida, ocorrendo na 2ª-3ª semana, com dor súbita, defesa/rigidez e pneumoperitônio — emergência cirúrgica.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A febre tifoide cursa tipicamente com leucopenia e desvio à esquerda, além de eosinopenia — diferente de outras infecções bacterianas que cursam com leucocitose.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A ceftriaxona endovenosa é a 1ª escolha nos casos graves/resistência; nos graves com choque, associa-se dexametasona, que reduz a mortalidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico